

Chest CT — preliminary image review

Study: Study0914085142459 · **Scan date:** 13 September 2026
Review date: 14 September 2026 · **Recorded patient:** male, 38 years

Main impression: No obvious focal lung mass or consolidation, pleural effusion, or pneumothorax was identified on this limited AI-assisted review. No convincing separate pulmonary nodule was identified to measure. These observations require confirmation by a radiologist.

Material and technique

Local chest CT DICOM study containing 1,403 objects in 12 series. Available images include 5 mm axial images before and after IV contrast, 1 mm reconstructions, and coronal/sagittal reformats. Lung, soft-tissue and bone windows were inspected. The actual images cover the chest and part of the upper abdomen despite an abdominal study label in the metadata. No signed diagnostic report or clinical history was available. [1]

Findings by region

Region	Preliminary observation
Upper, middle and lower lungs	No obvious discrete mass or convincing nodule; no focal air-space consolidation. Small or subtle abnormalities remain outside reliable exclusion by this review.
Central airways	The visible trachea and main bronchi appear open, without an obvious central obstructing lesion.
Pleura	No visible pleural fluid or pneumothorax.
Mediastinum and hila	No obvious bulky lymph-node enlargement. This is not a formal nodal measurement or staging assessment.
Heart and pericardium	No gross cardiac enlargement or large pericardial effusion apparent. This examination does not evaluate cardiac function or reliably assess coronary disease.
Chest wall and visible bones	No gross destructive bone lesion apparent on the inspected images; subtle bone abnormalities require a formal review.
Included upper abdomen	Tiny low-attenuation liver foci are visible, including in series 7, image 51. They are incompletely characterized on this chest examination; comparison with dedicated liver imaging and its official report is appropriate.

The source folder and image references are documented on pages 5–6. This document is an educational review, not a medical diagnosis or a substitute for the original radiologist’s report.

Interpretation, limitations and next steps

What the images do and do not show

The reviewed lung images do not provide a convincing target for a lung-nodule measurement or a lesion arrow. Small round white densities can represent vessels seen in cross-section; continuity on neighboring slices and multiplanar views helps distinguish them from nodules. Thin-section review is therefore relevant. [1, 3]

The right anterior basal soft-tissue contour is continuous with the liver dome on adjacent images (series 2, images 37–44). The reviewed right-sided sagittal images do not support labeling this as a definite diaphragmatic abnormality. It has not been reported as a lung mass. [1]

Pulmonary embolism: IV contrast images are present, but this study is not documented as a dedicated CT pulmonary angiogram. Pulmonary embolism cannot be reliably excluded by this review. A routine contrast chest CT and a dedicated pulmonary angiogram are different examinations. [4]

Rendered image review has less reliability than a radiologist's diagnostic workstation examination. Very small nodules, subtle ground-glass change, small airway disease and vascular abnormalities may be missed. A lack of an obvious abnormality here does not establish that symptoms are harmless or rule out cancer.

Recommended discussion with the treating doctor

1. **Obtain the signed radiology report** and compare it with the observations here; ask for review of the complete thin-section series. The formal interpretation should guide care. [2]
2. **Provide the reason for the scan and risk factors:** cough, fever, breathlessness, chest pain, coughing blood, smoking, previous cancer, chest surgery and prior CT examinations. These were not supplied.
3. **Clarify the tiny liver foci** using any existing dedicated liver imaging and official report. This chest review does not establish that they are cysts or assign another diagnosis.
4. **Decide follow-up from the confirmed findings.** There is no confirmed lung nodule here on which to base a surveillance schedule. Fleischner guidance applies to specific incidental nodules and has clinical exclusions; it should not be applied automatically. [3]

No medication, repeat CT interval, or surgical decision can be justified from this educational review alone.

Symptoms requiring prompt care

Seek emergency care for severe difficulty breathing, a tight/heavy chest, blue or grey lips, or sudden confusion. Coughing blood or new/worsening breathlessness needs urgent medical assessment. [5]

Source numbers refer to the references on page 6. The English and Arabic sections contain the same clinical conclusions.

التصوير المقطعي للصدر — مراجعة أولية للصور

معرف الدراسة: Study0914085142459

تاريخ الفحص: 13 سبتمبر 2026 · تاريخ المراجعة: 14 سبتمبر 2026

البيانات المسجلة: ذكر، 38 سنة

الخلاصة الأولية: لم تُلاحظ كتلة رئوية واضحة، أو منطقة تكثف رئوي بؤري، أو انصباب جنبي، أو استرواح صدر في هذه المراجعة المحدودة بمساعدة الذكاء الاصطناعي. لم تُحدد عقدة رئوية واضحة بما يكفي لتأكيد قياسيها. تحتاج هذه الملاحظات إلى تأكيد اختصاصي الأشعة.

المادة المتاحة وطريقة الفحص

دراسة محلية بصيغة DICOM تضم 1403 ملفات ضمن 12 سلسلة. تشمل الصور مقاطع محورية بسماكة 5 ملم قبل حقن الصبغة الوريدية وبعده، وإعادات بناء بسماكة 1 ملم، ومقاطع إكليلية وسهمية. روجعت نوافذ الرئة والأنسجة الرخوة والعظام. تُظهر الصور الصدر وجزءًا من أعلى البطن، رغم وجود وصف بطني في بيانات الدراسة. لم يتوفر تقرير تشخيصي موقع أو تاريخ مريض. [1]

الملاحظات بحسب المنطقة

المنطقة	الملاحظة الأولية
أعلى الرئتين ووسطهما وقاعدتهما	لا تظهر كتلة واضحة أو عقدة واضحة أو منطقة تكثف رئوي بؤري. لا يمكن استبعاد التغيرات الصغيرة أو الدقيقة بشكل موثوق بهذه المراجعة.
المجري الهوائية المركزية	تبدو القصبة الهوائية والشعبتان الرئيسيتان سالكة، دون آفة مركزية انسدادية واضحة.
غشاء الجنب	لا يظهر سائل حول الرئتين، ولا هواء في الحيز الجنب «استرواح صدر».
المنصف ونقيرا الرئتين	لا يظهر تضخم كبير وواضح في العقد اللمفاوية. لم يُجرَ قياس رسمي للعقد أو تقييم لمراحل الأورام.
القلب والتامور	لا يبدو القلب متضخمًا بشكل كبير، ولا يظهر انصباب تاموري كبير. لا يقيّم هذا الفحص وظيفة القلب أو أمراض الشرايين التاجية بصورة موثوقة.
جدار الصدر والعظام الظاهرة	لا تظهر آفة عظمية تخريبية كبيرة في الصور التي روجعت؛ أما التغيرات الدقيقة فتحتاج قراءة رسمية.
الجزء الظاهر من أعلى البطن	تظهر بؤر كبدية صغيرة جدًا منخفضة الكثافة، منها في السلسلة 7، الصورة 51. لا يمكن تحديد طبيعتها بهذا الفحص الصدري؛ تُقارن بتصوير الكبد المخصص وتقريره الرسمي.

ترد الصور المرجعية والمصادر في الصفحتين 5 و6. هذه مراجعة تعليمية وليست تشخيصًا طبيًا أو بديلًا عن تقرير اختصاصي الأشعة.

التفسير وحدود المراجعة والخطوات التالية

ما يمكن فهمه من الصور

لم تُظهر صور الرئة التي روجعت آفة واضحة لتحديد عقدة وقياسها أو وضع سهم عليها. قد تكون بعض النقاط البيضاء المستديرة أوعية دموية تظهر بالمقطع العرضي؛ ويساعد تتبّع اتصالها في الصور المجاورة والمقاطع المتعددة على تمييزها عن العقد. لهذا تفيد مراجعة المقاطع الرقيقة. [1، 3]

يتصل النسيج الظاهر عند القاعدة الأمامية اليمنى بقبة الكبد في الصور المتجاورة «السلسلة 2، الصور 37–44». لا تدعم المقاطع السهمية اليمنى التي روجعت اعتباره خللاً مؤكّداً في الحجاب الحاجز؛ ولم يُوصف بأنه كتلة رئوية. [1]

الانصمام الرئوي «الجلطة الرئوية»: توجد صور بعد الصبغة الوريدية، لكن الدراسة غير موثقة بوصفها تصويرًا وعائيًا مقطعيًا مخصصًا للشرابين الرئوية. لذلك لا يمكن استبعاد الانصمام الرئوي بشكل موثوق بهذه المراجعة. يختلف التصوير الروتيني للصدر بالصبغة عن التصوير الوعائي الرئوي المخصص. [4]

مراجعة الصور المعروضة أقل موثوقية من قراءة اختصاصي الأشعة على محطة تشخيصية. قد تُفوت العقد الصغيرة جدًا، وعتامات الزجاج المصنفر الدقيقة، وأمراض المجاري الهوائية الصغيرة، والتغيرات الوعائية. عدم ظهور خلل واضح هنا لا يثبت أن الأعراض غير خطيرة، ولا يستبعد السرطان.

ما يُنصح بمناقشته مع الطبيب المعالج

- الحصول على تقرير الأشعة الموقع ومقارنته بهذه الملاحظات، مع طلب مراجعة كامل سلسلة المقاطع الرقيقة. تُبنى الرعاية على التفسير الطبي الرسمي. [2]
 - توضيح سبب الفحص وعوامل الخطورة: السعال، والحمى، وضيق النفس، وألم الصدر، ونفث الدم، والتدخين، وأي سرطان أو جراحة صدر سابقة، والفحوص السابقة. لم تُقدّم هذه المعلومات.
 - توضيح طبيعة البؤر الكبدية الصغيرة بالرجوع إلى تصوير الكبد المخصص المتوفر وتقريره الرسمي. لا تثبت هذه المراجعة أنها أكياس، ولا تحدد تشخيصًا آخر لها.
 - تحديد المتابعة بناءً على النتائج المؤكدة. لم تُؤكّد هنا عقدة رئوية يمكن بناء جدول متابعة عليها. تخص إرشادات فليشّرن عقدًا عرضية محددة، ولها استثناءات سريرية؛ فلا تُطبّق تلقائيًا. [3]
- لا يمكن تبرير دواء أو موعد إعادة تصوير أو قرار جراحي اعتمادًا على هذه المراجعة التعليمية وحدها.

أعراض تستدعي عناية سريعة

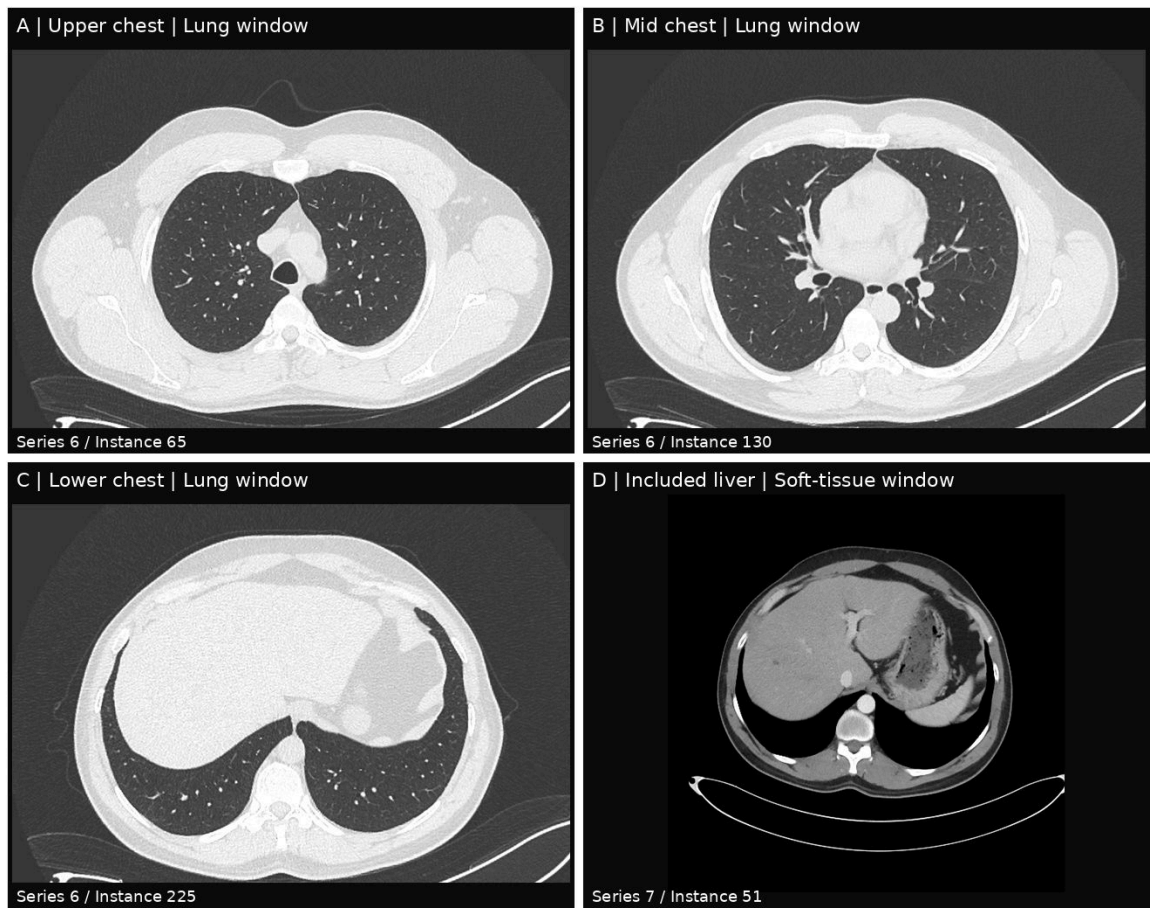
توجّه إلى الطوارئ عند صعوبة شديدة في التنفس، أو ثقل وضيق في الصدر، أو ازرقاق/رمادية الشفتين، أو ارتباك مفاجئ. يحتاج نفث الدم أو ضيق النفس الجديد أو المتفاقم إلى تقييم طبي عاجل. [5]

تشير الأرقام إلى المصادر في الصفحة 6. تتطابق الاستنتاجات السريرية في القسمين العربي والإنجليزي.

Representative images | صور مرجعية

Selected images illustrate the levels reviewed. They are not a complete diagnostic series and have no confirmed lung lesion marked. [1]

توضح الصور المختارة مستويات الصدر التي روجعت. لا تمثل كامل الدراسة التشخيصية، ولم توضع علامة على آفة رئوية مؤكدة. [1]



Display windows and proportional resizing only. No generative image modification. S = series; I = DICOM instance number. Image left is the patient's right in these axial views.

Panel / اللوحة	Reference / المرجع	Purpose / الغرض
A	S6 / I65	Upper chest — أعلى الصدر
B	S6 / I130	Mid chest — وسط الصدر
C	S6 / I225	Lower chest — أسفل الصدر
D	S7 / I51	Included liver; tiny foci remain uncharacterized. الجزء الظاهر من الكبد؛ طبيعة البؤر الصغيرة غير محددة.

اقتصر إعداد الصور على ضبط نافذة العرض وتغيير الحجم مع حفظ النسب. يسار الصورة المحورية يمثل يمين المريض. يشير الحرف S إلى السلسلة، والحرف I إلى رقم الصورة في بيانات الفحص.

Study inventory and references | المصادر

Local evidence [1]

Source: /home/ai/Desktop/sergery-05-09/chest-CT/Study0914085142459
Study date: 13 September 2026. Total: 1,403 DICOM objects. The inventory includes localizers and technical records as well as diagnostic images. The original files were not altered.

Series	Available reconstruction	Objects
1	Topogram	1
2 / 7	Precontrast / postcontrast axial, 5 mm	65 / 65
3 / 8	Precontrast / postcontrast coronal, 5 mm	64 / 63
4 / 9	Precontrast / postcontrast sagittal, 5 mm	93 / 95
5 / 6 / 10	Thin axial reconstructions, 1 mm; series 6 uses a lung kernel	335 / 289 / 331
501 / 502	Dose record / technical protocol image	1 / 1

Review scope: All 65 series-2 axial images and all 288 non-localizer series-6 thin lung images were inspected, with additional contrast, multiplanar, soft-tissue and bone-window review. Other reconstructions were sampled. No earlier chest study was available for comparison.

شملت المراجعة الصور المحورية الـ 65 في السلسلة 2 والمقاطع الرئوية الرقيقة الـ 288 غير الاستطلاعية في السلسلة 6، مع صور إضافية بالصبغة ومقاطع متعددة ونوافذ الأنسجة الرخوة والعظام. روجعت عينات من بقية إعدادات البناء. لم تتوفر دراسة صدر أقدم للمقارنة. لا يشكل سجل الجرعة أو صورة البروتوكول تقريراً تشخيصياً.

External references

These sources explain terminology and clinical limits; they do not independently diagnose this patient. Accessed 14 September 2026. Searches used general medical terms, without patient identifiers.

2. **ACR/RSNA, RadiologyInfo.** [Chest CT](#). Reviewed 15 July 2026. Examination scope and the role of the radiologist's report.
3. **MacMahon H, et al.** [Guidelines for Management of Incidental Pulmonary Nodules Detected on CT Images: From the Fleischner Society 2017](#). Radiology 284:228–243. Thin-section assessment and limits of incidental-nodule guidance.
4. **American College of Radiology.** [ACR Appropriateness Criteria: Suspected Pulmonary Embolism](#). Revised 2022. Dedicated pulmonary vascular imaging versus routine contrast chest CT.
5. **NHS.** [Shortness of breath](#). Symptom-based urgency guidance.

تشرح المراجع الخارجية المصطلحات وحدود التقييم، ولا تشخص حالة هذا المريض بصورة مستقلة. أُجري البحث بمصطلحات طبية عامة دون إرسال معرّفات المريض.